Nové odporúčania pre dyslipidémiu: prečo ich treba čítať kriticky

Autor: Kenny Lin, MD (Medscape); Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 17.05.2026



Ilustračná scéna. Ani usmernenie nie je jednoliate — časť odporúčaní stojí na slabšom dôkazovom základe.

Nové odporúčania American College of Cardiology a American Heart Association pre manažment dyslipidémie prinášajú viacero významných zmien. Menia spôsob odhadu kardiovaskulárneho rizika, rozširujú používanie doplnkových vyšetrení a vracajú do klinickej praxe cieľové hodnoty LDL cholesterolu. Zároveň však vyvolávajú otázky, nakoľko sú metodologicky pevné a použiteľné v každodennej primárnej starostlivosti.

Podľa komentára Dr. Kennyho Lina, rodinného lekára a autora blogu *Common Sense Family Doctor*, by sa lekári nemali pozerať iba na samotné odporúčania, ale aj na kvalitu procesu, ktorým vznikli.

Čo nové odporúčania prinášajú

Jednou z hlavných zmien je nahradenie pôvodných *Pooled Cohort Equations* novým kalkulátorom **PREVENT**, ktorý má slúžiť na odhad budúceho kardiovaskulárneho rizika a usmernenie lipidovej liečby.

Odporúčania zároveň:

- znižujú hranice 10-ročného rizika pre začatie liečby statínom,
- rozširujú použitie skóre koronárneho kalcia,
- odporúčajú častejšie meranie lipoproteínu(a),
- znovu zavádzajú cieľové hodnoty LDL cholesterolu,
- odporúčajú pravidelné kontroly lipidového profilu na overenie účinku režimových opatrení a farmakoterapie.

Tieto zmeny môžu v praxi viesť k tomu, že väčší počet pacientov bude považovaný za kandidátov na hypolipidemickú liečbu.

Konflikty záujmov: prijateľné, ale nie ideálne

Jednou z otázok pri hodnotení odporúčaní je, či ich autori boli nezávislí od farmaceutického alebo technologického priemyslu. Z 33 autorov nového dokumentu malo 12 deklarované relevantné finančné konflikty záujmov. Predseda ani podpredseda panelu ich podľa dostupných údajov nemali.

To nie je dokonalý stav, ale podľa Lina nejde o zásadné zlyhanie. Približne tretina autorov s konfliktmi záujmov je podľa neho ešte prijateľná, hoci nižší počet by bol dôveryhodnejší.

Chýbajúci hlas primárnej starostlivosti

Závažnejší problém predstavuje absencia významných organizácií primárnej starostlivosti. Hoci nové odporúčania podporilo viacero odborných spoločností, nezapojili sa American Academy of Family Physicians ani American College of Physicians.

Práve tieto organizácie zastupujú veľkú časť lekárov, ktorí sa v každodennej praxi venujú prevencii kardiovaskulárnych ochorení u dospelých. Ich neúčasť súvisela s výhradami k metodike tvorby odporúčaní.

To je dôležité. Odporúčanie, ktoré má zásadne ovplyvniť preventívnu liečbu miliónov pacientov, by malo pevne stáť aj na skúsenosti lekárov prvej línie.

Problém so systematickým prehľadom dôkazov

Ďalšou slabinou je, že odporúčania nevznikli na základe nezávislých systematických prehľadov vopred definovaných klinických otázok. Autori síce uvádzajú, že vykonali rozsiahle preskúmanie literatúry vo viacerých databázach, no bez presného zverejnenia vyhľadávacích stratégií, kritérií zaradenia a metodiky nie je možné posúdiť, či bol výber dôkazov skutočne úplný.

Iné odporúčania pre lipidový manažment — napríklad odporúčania US Preventive Services Task Force z roku 2022 alebo VA/DoD z roku 2025 — sa o systematické prehľady opierali. V tomto porovnaní pôsobí metodika ACC/AHA menej presvedčivo.

Pre klinika to znamená jednoduchú vec: odporúčania treba čítať ako dôležitý odborný dokument, nie ako nedotknuteľnú pravdu.

Pacientove preferencie zostali na okraji

V paneli bol síce uvedený jeden zástupca pacientov, čo je pozitívne. Jeden človek však nemôže reprezentovať široké spektrum pacientskych hodnôt, obáv a preferencií.

Toto je pri preventívnej liečbe zásadné. Statínová liečba sa často ponúka ľuďom bez aktuálnych ťažkostí, pri ktorých ide o zníženie budúceho rizika. Časť pacientov môže aj pri objektívne merateľnom prínose liečbu odmietnuť, najmä ak je absolútny prínos malý.

Lin upozorňuje na štúdiu, podľa ktorej by pri 10-ročnom kardiovaskulárnom riziku 10 % viac ako 40 % dospelých v USA odmietlo statín aj v hypotetickej situácii, že by znížil ich absolútne riziko až na nulu. V realite je prínos statínu podstatne menší — približne o **2,5 percentuálneho bodu**.

To neznamená, že statíny nie sú užitočné. Znamená to, že pacient má rozumieť absolútnemu prínosu, možným nežiaducim účinkom, alternatívam a vlastnej miere ochoty užívať dlhodobú preventívnu liečbu.

Praktický záver

Nové odporúčania ACC/AHA pre dyslipidémiu prinášajú viacero klinicky významných noviniek. Môžu pomôcť presnejšie stratifikovať riziko a viesť liečbu podľa cieľových hodnôt LDL cholesterolu. Zároveň však majú metodologické slabiny: slabšie zastúpenie primárnej starostlivosti, absenciu nezávislého systematického prehľadu a nedostatočné zapracovanie pacientskych preferencií.

Pre prax z toho vyplýva triezvy postoj. Odporúčania treba poznať, ale nie mechanicky preberať. Pri rozhodovaní o liečbe dyslipidémie by mal lekár kombinovať odborné odporúčania, individuálne kardiovaskulárne riziko, komorbidity, očakávaný absolútny prínos liečby a preferencie pacienta.

Inými slovami: nové odporúčania sú dôležité, ale zaslúžia si kritické čítanie.

Zdroj: Kenny Lin, MD: *Grading the New Dyslipidemia Guidelines*, Medscape, 2026. Dostupné na: medscape.com

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=nove-odporucania-pre-dyslipidemiu-preco-ich-treba-citat-kriticky · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.